

결정하기 전, 이것만 확인하세요

Q1 MRI에서 파열이 보이면 수술하나요?

퇴행성 파열은 증상과 관절염 정도에 따라 비수술 치료를 먼저 고려합니다.

Q2 봉합과 절제 중 무엇이 좋나요?

위치·혈류·모양·조직 상태에 따라 보존 가능성을 판단합니다.

Q3 절제하면 관절염이 오나요?

연골판이 줄면 부담이 커질 수 있어 필요한 만큼만 정리합니다.

바로 진료가 필요한 신호

- 찢어진 조직 때문에 무릎이 실제로 펴지지 않는 잠김
- 외상 뒤 부종이 빠르게 커지고 체중을 싣기 어려움

수술 권유를 받았더라도 다시 확인할 수 있습니다

수술 권유를 받았어도 다시 확인할 수 있습니다.
증상·진찰·영상에 맞는지, 비수술 선택지와 수술 범위를 설명합니다.



김동희 원장

정형외과 전문의 · 무릎
관절경 · 스포츠 손상

검사와 영상을 직접 설명하고 필요한
치료 범위를 상담합니다.

진료 전에 가져오세요

- 최근 영상 CD·판독지
- 치료·수술 이력
- 복용 중인 약·알레르기

대표 전화 031-328-0333

경기도 용인시 처인구 중부대로 1539

진료 일정은 방문 전 대표 전화로 확인해 주세요.

이 자료는 일반적인 환자 교육용입니다. 개인별 치료 계획은 진찰과 검사
결과에 따라 달라집니다.

환자·보호자용 치료 안내

반월상 연골판 파열

파열 모양과 혈류, 증상을 보고 가능한 범위에서
연골판을 보존합니다.



질환과 치료를 이해하기 위한 해부 그림

관절 내시경 봉합술·부분 절제술

찢어졌다고 모두 제거하지 않습니다. 봉합
가능성과 남길 수 있는 건강한 연골판 범위를 먼저
확인합니다.

01 질환·증상

반월상 연골판은 무릎 충격을 분산하고 안정성을 돕는 섬유연골입니다. 외상 또는 퇴행성 변화로 찢어질 수 있습니다.



이런 증상을 확인합니다

- 무릎 안쪽·바깥쪽 관절선 통증
- 쫓그리기·회전 때 걸림과 찢릿함
- 붓기 또는 완전히 펴지지 않는 잠김

진단의 핵심

영상만으로 수술을 결정하지 않습니다.
증상·진찰·영상이 같은 부위를 가리키는지 확인합니다.

02 치료 선택

증상·진찰·영상·치료 반응·회복 목표를 함께 보고 결정합니다.

먼저 해볼 치료

- 활동 조절·약물·근력 재활
- 퇴행성 파열은 관절염과 증상에 따라 경과 관찰
- 통증·잠김·부종 변화 재평가

수술을 검토할 때

- 무릎이 잠기거나 불안정 조각이 의심
- 비수술 치료 뒤에도 통증과 기능 제한이 지속
- 봉합 가능한 급성 파열 또는 동반 인대 수술이 있을 때

치료의 흐름

비수술 치료

기능 재평가

필요 시 수술

03 수술·회복

관절 내시경 봉합술·부분 절제술



- 가 관절경으로 파열 위치·조직·연골 상태 확인
- 나 봉합 가능하면 연골판 보존을 우선 고려
- 다 회복이 어려운 불안정 조각만 제한적으로 정리

회복은 날짜보다 기능 기준으로

- 초기 | 봉합 여부에 따라 체중 부하·굽힘 조절
- 중기 | 부종 없이 관절 운동·허벅지 근력 회복
- 복귀 | 봉합 치유 또는 증상 반응으로 단계 결정

알아둘 위험과 한계

감염, 혈전, 관절 강직, 통증 지속, 재파열, 연골 손상 진행, 추가 수술 가능성이 있습니다.